帕金森病 16例社区家庭护理干预

衡瑞蕊,祝建玲
(胜利石油管理局河口钻井卫生院　山东 东营 257200)

摘　要　目的:探讨社区家庭护理干预对帕金森病患者(PD)生活质量和运动功能的影响。方法:将 32例 PD患者随机分为实验组和对照组各 16例,实验组给予社区家庭护理干预,对照组仅给予常规护理,干预 2年后分别采用 PD统一评分量表(UPDRS)和 PD运动功能评分量表(MDRSPD)评定两组患者生活质量和运动功能情况。结果:两组患者生活质量和运动功能比较均有统计学意义(P<0.05)。结论:对 PD患者进行社区家庭护理干预有利于缓解症状,提高生活质量。

关键词　帕金森病;社区家庭护理;生活质量
中图分类号:R473.5　　**文献标识码**:A　　**文章编号**:1006-7256(2010)24-0040-02

2007年 9～2009年 9月,我们对 16例帕金森病(PD)患者行社区家庭护理干预,效果满意。现报告如下。

1　资料与方法

1.1　临床资料　本组 PD患者 32例,男 17例,女 15例;年龄 53～68岁;患病年限 2～15年,平均 8年。文化程度:初中以上 22例,小学 10例。其中丧偶 4例。健康状况:基本健康 18例,半自理 10例,不能自理 4例。均为河口地区参与社区居民建档的家庭,常住人口户型,均无器质性疾病和精神病病史,符合中华医学会 PD诊治标准。随机分为实验组与对照组各 16例,两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2　方法　对照组按一般护理常规进行护理。实验组除按一般护理常规护理外,由医护人员采用电话随访和家访对患者和家属进行心理、生理、运动与康复、知识缺乏、饮食、服药及语言沟通障碍方面的健康干预,并记录档案[1]。

1.3　评价方法　①生活质量采用 PD统一评分量表(UPDRS)进行评分,该量表有 26个小项,评分采用五级四分法,总分 87分,归纳三类,病理症状 63分,自理能力 8分,思维能力 16分,UPDRS是目前国际上普遍采用的量表,分值越高生活质量越差。②运动功能测量选择 PD运动功能评分量表(MDRSPD)[2]进行测量,它包括 16项内容,评分采用五级四分法,总分 64分,归纳三类,起坐步态姿势 44分,言语和书写 8分,日常运动 12分,分值越高,PD症状越严重。MDRSPD运动功能及临界症状相关性能很好,有较好的信度与效度。③评估采用会谈式问卷调查,向患者解释调查目的和内容,征得其同意后,发放问卷,由熟悉患者情况的家属或照顾者填写,共发放 32份,回收 32份,有效率 100%。

1.4　统计学方法　应用 SPSS11.0统计软件进行数据分析,计量资料采用 t检验。检验水准 α=0.05。

2　结果

2.1　两组患者干预前后生活质量评估比较　见表 1。

2.2　两组患者干预前后运动功能比较　见表 2。

3　社区家庭护理干预

3.1　健康教育　向患者和家属讲解 PD的相关知识,包括 PD的病因、诱发因素及治疗情况,如何识别并发症的先兆,以提高其对 PD的认识程度。

3.2　督促患者正确服药　PD患者的症状受服用药物及药物

表 1　两组患者干预前后生活质量评估比较(分,$\bar{x}\pm s$)

组别	n	病理症状	自理能力	思维能力	总评分
实验组					
干预前	16	28.13±3.09	3.56±0.39	7.06±0.78	38.75±4.26
干预后	16	26.72±2.96*	3.42±0.37*	6.64±0.73*	36.78±4.06*
对照组					
干预前	16	27.38±3.12	3.48±0.40	7.12±0.81	37.98±4.33
未干预	16	29.57±3.34	3.83±0.44	7.76±0.88	41.16±4.66

注:与干预后对照组比较,* P<0.05

膏、夹板外固定,这些操作会增加患者的恐惧感[1]。空姐护士和护理人员应主动关心和安慰患者,用亲切、热情的态度向患者详细介绍住院环境、主管医生、主管护士,做好订餐等工作,使患者减轻思想负担,消除恐惧感,使患者安心接受治疗。

3.2　提升我院的护理服务文化　"空姐式免陪护"是我院护理部 2009年推出的护理品牌,核心是以人为本,尊重患者的需要。我院通过开展"空姐式免陪护"护理,以患者为中心,调动了护理人员工作的积极性。护理工作得到了患者及其家属的肯定,极大地提高了护理服务质量,推动了护理工作的发展。

3.3　提高社会效益和经济效益　媒体多次报道,社会反应热烈,很多医院同行到我院参观及交流,提出很多宝贵意见,增进了我院与他院的合作、交流,为我院创造了良好的社会效益和经济效益,提高了我院护理品牌的知名度。

3.4　提高患者满意度　"空姐式免陪护"服务实施半年多来骨科护理工作出现了零投诉,我院被评为广东省文明"窗口"单位,骨科中心晋升为省级青年文明号"三星级"集体。"空姐式免陪护"是一大亮点,骨科患者满意度保持在 98%以上,很多患者慕名而来,收到了满意的效果。

参考文献:

[1]　刘红梅,马永洪,杨芳明.心理护理对创伤骨科患者早期功能锻炼依从性的影响[J].护理实践与研究,2009,6(12):4-6.

本文编辑:孙衍鲲　　2010-05-08收稿

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 2 两组患者干预前后运动功能比较 (分，$\bar{x}\pm s$)

组别	n	起坐步态姿势	言语和书写	日常运动	总评分
实验组					
干预前	16	19.50±2.15	2.81±0.31	6.13±0.67	28.44±3.13
干预后	16	18.53±2.04*	2.70±0.30*	5.82±0.64*	27.05±2.98*
对照组					
干预前	16	20.40±2.20	2.76±0.28	6.34±0.65	29.50±3.13
未干预	16	22.44±2.42	3.01±0.31	6.85±0.70	32.30±3.43

注：与干预后对照组比较，* P<0.05

剂量、服用时间等影响。药物治疗时详细告知服药的时间、剂量及其不良反应，不能自行停药、换药，服用多巴胺类药物期间，应避免进高蛋白饮食，时间相差半小时以上，因为蛋白质中的中性氨基酸与多巴胺竞争入脑，影响其疗效。药物从小剂量开始，逐步增加药量，在服药期间禁服维生素 B6、单胺氧化酶 A抑制剂，以免加重不良反应。长期服用时要注意观察有无不良反应，定期复查肝、肾功能等。

3.3 运动与康复 PD目前尚无特殊的治疗方法，在坚持药物治疗的同时，运动与康复对预防病情加重、并发症的发生非常重要[3]。首先帮助患者选择适合自己的运动方式，然后制定一个现实的目标，并采取循序渐进的方法进行运动；让患者每日进行头颈、躯干、上肢及肩、手部的锻炼等，对运动不便或长期卧床者，每日进行肢体被动运动数次。有条件者定期到医院参加由康复医生指导的康复训练。

3.4 安全护理 ①居家安全：生活环境应从安全角度考虑，居室内物品摆放固定、有序、光线充足，如厕下蹲起立困难时可用高凳坐位排便，卧室和卫生间的地面须防滑；浴缸处设安全扶手，浴缸底部放置防滑垫等。②行走安全：PD可致步距减小，体态屈曲，前冲，缺乏平衡感，因此容易摔倒。指导患者穿防滑鞋，走路时，将脚抬高，脚跟着地后再迈出另一步，保持正确姿势，摆动双臂并双目向前，每跨一步都要跨越一条平行线；转身时尽量不要转弯，而是以弧线前进，身体跟着移动，行走困难时可用手杖助行等，外出活动时需有人陪护。

3.5 心理护理 抑郁在 PD患者中常见，近一半患者受此困扰，部分患者以抑郁为首发症状[4]。保持良好的心理是治疗 PD的根本措施。家庭成员应在精神上给予安慰、关心、理解，尊重患者的性格和生活习惯，帮助患者走出心理误区，询问他们的想法、感觉，让他们倾诉自己的苦闷；尽量让患者参与家庭决策，给患者展示自我价值的机会；多参加必要的社交活动；教会患者心理调适的技巧。

3.6 饮食指导 饮食治疗是 PD的辅助治疗方法之一，嗅觉障碍在 PD患者中颇为常见且比较严重，致使食欲减退，因此应采取各种护理方法增进食欲[5]。便秘在 PD患者中较常见，患者要养成每天定时排便的习惯，摄入足够的水、新鲜蔬菜、水果、富含纤维素的食物或服用蜂蜜防治便秘。吞咽困难者可用食品机把食物打成黏稠糊状，进食速度宜慢，且少量多餐，以免进食过快引起噎塞和呛咳。

3.7 语言沟通障碍指导 PD患者因口、咽和腭肌运动障碍使讲话缓慢、语调变低，严重时发音单调、吐字不清，使他人难以听懂，家庭成员应该以同情、宽容和关爱的态度对待患者，给患者足够的时间表达清楚自己的需求，不对患者说有损其自尊的话，鼓励其大声朗读或唱歌，并经常参与亲友的交谈。

3.8 预防并发症 注意居室的温度、湿度、通风、采光等，根据季节、气候等增减衣服决定户外活动的方式、强度，以上措施均能有效地预防感冒。晚期卧床患者要定时翻身，做好皮肤护理，防止尿、便浸渍及压疮的发生。被动活动肢体，加强肌肉、关节按摩，对延缓骨关节的并发症有意义。做好口腔护理，经常翻身、叩背，以预防吸入性肺炎和坠积性肺炎。

4 讨论

PD是一种慢性进行性疾病，严重地影响患者的生活质量。据统计，90%的患者住在家中，因此恰当的家庭护理干预有助于提高患者的生活质量，延缓病程的进展[1]。本研究结果显示，经过 2年的护理干预，实验组生活质量优于对照组，两组干预主效应和时间主效应差异均有统计学意义（P<0.05）。说明本干预方法能显著提高 PD患者的生活质量。PD的药物治疗和手术治疗虽然能使患者的症状在一定时间内获得一定程度的好转，但皆不能阻止本病的自然进展，现有的药物只能在不同程度上减轻症状，防止并发症发生而延长患者的生命，由于进行性加重的静止性震颤，肌强直、运动减少及体位不稳定等，导致患者的生活质量显著下降，使患者在生理、心理上均面临着许多需要干预的问题。目前，国外在 PD康复护理的组织管理、宣传教育、运动锻炼指导，药物治疗、营养支持、心理支持、社会支持等多方面都有比较深入的研究，而我国 PD的护理普遍存在不系统、不完善等问题，因此，由专业的护理工作者指导 PD患者对其进行康复护理，加强关节活动范围和肌力的锻炼，对减缓患者严重肌强直、继发性关节强直发生及提高生活质量有着重要意义。对 PD患者和家属同步实施认知干预，可提高其对该病的认识，从而提高对患者的照护水平，使患者的整体生活质量明显提高。

PD患者常常产生自卑、忧郁心理，他们拒绝社交活动，整日沉默寡言，闷闷不乐。随着病程延长，病情进行性加重，可产生焦虑、恐惧甚至绝望的情绪，不仅会加重患者的症状，同时也会使患者因害怕人际交往而不配合功能锻炼，最终长期卧床而导致肺炎、压疮、泌尿系统感染等并发症。另一方面，长期的心理压力使患者不积极配合治疗，影响治疗效果。因此在帮助患者维持良好的情绪的基础上，要定期给患者家属讲解疾病的相关知识，使患者家属了解患者的心理状况和抑郁、焦虑产生的原因，获得患者家属对患者的理解和配合，帮助患者与家属建立和睦的家庭关系，提升患者在家庭中的自我价值，从而提高生活质量。

参考文献：

[1] 古成璠，袁丹，鲁政.帕金森患者的家庭护理 [J].护理研究，2002，16(11)：681.

[2] 陈海发，曾湘豫，张文记，等.帕金森病运动功能评分量表及一致性和敏感性检验及其优越性体现 [J].中国临床康复，2004，8(4)：762－763.

[3] 肖爱华.护理干预对帕金森氏病出院病人日常生活能力的影响 [J].护理实践与研究，2005，2(6)：7－8.

[4] 朱海燕，谢国碧.浅谈对住院患者的心理辅导 [J].西藏医药杂志，2001，22(2)：68.

[5] 吴波.帕金森病与嗅觉障碍 [J].国外医学：神经病学神经外科学分册，2004，31(4)：322－324.

本文编辑：牟丽洁 2010－05－21收稿

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net